Cuidados en Epidermólisis bullosa

NATIVIDAD ROMERO HARO*[1], NORA GARCÍA GARCÍA[2], AIRA MEGÍAS CAMPOS[3]

[1]ENFERMERA
[2]PSICÓLOGA
[3]TRABAJADORA SOCIAL
ASOCIACIÓN DEBRA – PIEL DE MARIPOSA
*Autora para correspondencia: enfermera@debra.es

Recibido: 25 de mayo de 2018 – Aceptado: 13 de junio de 2018

Resumen

En este artículo vamos a describir la Epidermólisis bullosa y sus cuidados principales desde un punto de vista holístico, en el que se presta gran importancia a los cuidados clínicos y de enfermería, como la cura de las ampollas y heridas, pero sin dejar de lado la importancia de los cuidados en los ámbitos psicológico y social. Ya que en muchos casos un buen abordaje en materia psicológica y social en las personas que padecen esta enfermedad de baja prevalencia va a permitir que los cuidados clínicos y de enfermería se desarrollen de forma más satisfactoria y acorde a las necesidades de cada persona.

Palabras clave: Epidermólisis bullosa (EB) – Cuidados enfermería – Procedimiento de curas – Cuidados psicosociales.

Abstract

Epidermolysis bullosa care

In this article we are going to describe Epidermolysis bullosa and the recommended care from a holistic point of view. Great importance will be given to clinical and nursing care, including the care of blisters and wounds, without neglecting the importance of care in the psychological and social fields. In many cases a good approach of psychological and social matters affecting the sufferer will allow clinical and nursing care to be developed successfully and according to the needs of each person.

Key words: Epidermolysis bullosa (EB) – Nursing care – Management dressing – Psychosocial care.

INTRODUCCIÓN

La Epidermólisis bullosa o ampollosa (EB o EA) hereditaria es una genodermatosis (dermatosis de causa genética en cuyo origen no influyen factores ambientales) de muy baja prevalencia, transmitida de forma autosómica dominante o recesiva y causada por una alteración de las proteínas de la unión epidermodérmica que altera la cohesión de la dermis con la epidermis, hecho que da lugar a la formación de ampollas y erosiones cutáneas y mucosas. [1]

La Epidermólisis bullosa (EB) tiene una presentación diversa desde formas más leves a otras más graves, que afectan a la piel y las mucosas y que suponen, como ya hemos dicho, la formación de ampollas y vesículas tras mínimos traumatismos, con afectación variable de otros órganos. No existe un tratamiento específico, y su evolución es crónica, llegando a mermar la calidad de vida de las personas afectadas y su supervivencia, lo cual supone un reto tanto para la persona afectada, como para los familiares y los profesionales que los atienden.

Partiendo de esta definición de la EB, y considerando que de forma general la enfermedad se manifiesta y diagnostica en los primeros días de vida, podemos contemplar la EB como una enfermedad familiar que afecta a todos los ámbitos de la persona que la padece y que, además, impacta de una forma drástica en el núcleo familiar y sus componentes. Al tratarse de una enfermedad crónica y, en muchos casos, pluripatológica es necesario un abordaje integral de la persona afectada. Por tanto, definimos los cuidados en la EB como: el abordaje y manejo de las complicaciones que se manifiestan en los aspectos clínicos, psicológicos y sociales de la persona. [1]

En la Asociación DEBRA-PIEL de MARIPOSA trabajamos un equipo compuesto por enfermeras, trabajadoras sociales y psicóloga que damos formación, soporte y apoyo a las familias con esta enfermedad. En base a nuestra experiencia como profesionales vinculadas con esta enfermedad, vamos a exponer unas recomendaciones sobre los cuidados en la EB, centrándonos en los aspectos más clínicos, pero por supuesto, sin dejar de lado los cuidados psicológicos y sociales, tan necesarios en esta enfermedad ya que, en numerosas ocasiones, sin un buen cuidado en estos últimos aspectos, no podríamos abordar de forma satisfactoria los cuidados sanitarios.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA EB

Las enfermeras debemos conocer bien la EB, sus peculiaridades y sus complicaciones para poder informar y formar sobre ellas, ya que los cuidados de enfermería en la EB empiezan con la educación a la familia. Ante una enfermedad crónica como ésta, es recomendable instruir a la persona cuidadora principal con el objetivo de que sea una aliada en los cuidados, por ejemplo, detectando cambios de forma inmediata y trasladándolos al profesional correspondiente. Además, gracias al papel de cercanía de la enfermera con la persona afectada y su entorno, conocer a fondo la enfermedad nos ayuda a prevenir o retrasar las posibles complicaciones y, a posteriori, una vez se hayan manifestado, podremos detectarlas de forma precoz para tratarlas cuanto antes y así disminuir el agravamiento de los síntomas. *(Foto 1)*



Foto 1. Enfermeras con familia.

El cuidado de la piel y las mucosas en EB es una de las primeras tareas que las enfermeras debemos llevar a cabo. Para ello, podemos seguir una rutina de cura que permitirá dar los mejores cuidados de una manera ágil.

El primer paso en dichos cuidados es conocer que procedimientos o actividades debemos adaptar para que el cuidado de la persona con EB se haga de la mejor forma posible y no causar daños adicionales, por ejemplo, debemos saber que está contraindicado el roce, fricción o deslizamiento de la piel por el elevado riesgo de crear ampollas y/o heridas. Por tanto, debemos manipular a la persona con sumo cuidado en todo momento, preguntando cuales son las zonas más resistentes y cuál es la mejor forma para tocar la piel o agarrar a la persona. *(Foto 2)*

También está contraindicado el uso de elementos adhesivos en la piel, por el riesgo de crear lesiones en su retirada, por tanto, debemos seleccionar cuidadosamente el material que vamos a utilizar durante el cuidado de las heridas. *(Foto 3)*



Foto 2. Cómo coger a una persona con EB.

El segundo paso en los cuidados es la prevención de la aparición de ampollas, para ello vamos a utilizar productos que nos ayuden a fortalecer la piel y a protegerla, como son los Ácidos Grasos Hiper Oxigenados (AGHO) y la protección mecánica con vendajes en zonas de roce o propensas a la aparición de ampollas y erosiones, respectivamente. *(Foto 4)*



Foto 3. Materiales usados en EB.



Foto 4. Vendajes protectores.

El tercer paso es la cura de las ampollas y lesiones. En EB las ampollas deben puncionarse siempre para extraer el contenido líquido, ya que el no puncionarlas hace que se puedan extender provocando dolor y con el consiguiente riesgo de que aparezca una herida más grande. Se debe pinchar la ampolla con una aguja o una hoja de bisturí y presionar suavemente con unas gasas para extraer el líquido que contiene. Mantendremos el techo de la ampolla salvo que ésta presente contenido purulento, en este caso recortaremos el techo con mucho cuidado para permitir una buena limpieza de la zona. *(Foto 5)*

Las heridas en EB se curan con el proceso habitual de cura de una lesión, centrándonos en el uso de la cura en ambiente húmedo (CAH) como el método más apropiado. En primer lugar, se debe hacer una limpieza de la herida, normalmente esta limpieza se acompaña de la ducha o baño, de forma general cada 48 horas puesto que son curas largas, entre 2 y 4 horas, y se intentan espaciar para conciliar con el resto de rutinas diarias. En el baño utilizaremos geles sin jabón, para evitar la sequedad de la piel, geles con avena, para disminuir el prurito (una de las complicaciones más frecuentes en EB) y/o geles antisépticos para favorecer la desinfección.



Foto 5. Ampolla en EB.

Emplearemos para lavar el cuerpo una compresa estéril de un solo uso para evitar la proliferación de microorganismos que podría suponer la esponja tradicional. Tras el baño, secaremos con una toalla (siempre mediante pequeños toques evitando la fricción) y después procederemos a la cura de las lesiones. *(Foto 6)*



Foto 6. Baño en EB.



Foto 7. Gastrostomía en EB.

Tras el baño, procederemos a la cura de las lesiones. Podemos utilizar en la herida productos o geles que ayudan a la limpieza, descontaminación y cicatrización, como: Prontosan® gel, Cicactiv®, RYM® (cicatrizante o quemaduras), entre otros, siempre extendiendo una capa fina sobre el lecho de la herida. Mención especial a las cremas barreras que utilizaremos alrededor de heridas con abundante exudado o alrededor de la gastrostomía que muchas de las personas afectadas con EB tienen insertada, a consecuencia de las complicaciones digestivas como la disfagia y la estenosis esofágica que conllevan a problemas nutricionales severos. *(Foto 7)*

Posteriormente, a la aplicación de las cremas, colocaremos los apósitos de elección. Los apósitos que debemos utilizar serán siempre apósitos sin adhesivo para evitar el daño a la piel en su retirada. Además, los apósitos deben cumplir otras características como buena gestión del exudado; flexibilidad para poder utilizarlos en zonas de amplio movimiento como articulaciones; capacidad de gestionar la carga microbiana para poder emplearlos en el tratamiento local de infecciones; etc. Utilizaremos unos apósitos u otros en función de las características de cada herida y las preferencias de la persona afectada. Un ejemplo de los apósitos más utilizados en EB, en base a la experiencia de las enfermeras de la Asociación DEBRA-PIEL DE MARIPOSA es:

Normalmente, colocaremos un apósito primario y luego uno secundario, en función de la cantidad de exudado elegiremos una combinación de apósitos u otra. Siempre considerando que realizaremos la cura, en principio, cada 48 horas y por tanto, debemos permitir a la persona tener una buena calidad de vida en esos días que no hay cura, teniendo en cuenta la comodidad, gestión del olor, entre otros factores importantes. *(Foto 8)*

Tras la colocación de los apósitos, debemos proceder a la hidratación de la piel sana que no presenta heridas. Una buena hidratación de la piel permite unas mejores condiciones de flexibilidad y estabilidad que pueden prevenir la aparición de ampollas. En este sentido, como ya hemos nombrado anteriormente, utilizaremos AGHO en aquellas zonas más propensas a la aparición de heridas o expuestas a mayor roce. Del mismo modo, aplicaremos estos productos en las zonas ya cicatrizadas pero que mantienen una coloración diferente al resto de la piel. Para la hidratación del resto del cuerpo podemos utilizar cremas ricas en avena, con propiedades antipruriginosas, etc.

Por último, debemos aplicar vendajes en todas aquellas zonas donde hemos colocado apósitos ya que, al ser apósitos no adhesivos, debemos mantenerlos fijos en su lugar. Para ello, podemos utilizar vendas suaves, como Easifix® y/o malla tubular, como Tubifast® o Tensofast®. Otra buena alternativa

FAMILIA DE APÓSITOS	NOMBRE APÓSITO e INDICACIONES
Hidrocoloides: Hidrofibra de hidrocoloide:	▪ Urgotul® Flex: Heridas de bajo exudado, tanto agudas como crónicas en la etapa de granulación y epitelización. Flexible y fácilmente adaptable a diferentes zonas del cuerpo. ▪ Aquacel® Extra: Heridas con exudado de moderado a alto, tanto agudas como crónicas.
Espumas de poliuretano:	▪ Mepilex® Transfer: Heridas de poco-medio exudado, tanto agudas como crónicas. Flexible y fácilmente adaptable a diferentes zonas del cuerpo. *Transfiere el exudado fuera del lecho de la lesión, si hay bastante exudado, necesita apósito secundario. ▪ Mepilex® Lite: Heridas de poco-medio exudado, tanto agudas como crónicas. Flexible y fácilmente adaptable a diferentes zonas del cuerpo. ▪ Mepilex®: Heridas con alto exudado, tanto agudas como crónicas o como protección mecánica en zonas de roce, por ejemplo, rodillas.
Alginatos:	▪ Exufiber®: Heridas de exudado abundante-alto, tanto agudas como crónicas. *Se recomienda utilizar este alginato o cualquier otro con una primera capa de contacto de fácil retirada por el riesgo de que el apósito quede adherido. ▪ UrgoClean®: Heridas de exudado abundante-alto, tanto agudas como crónicas.
Antimicrobianos: Platas:	▪ PolyMem®: Heridas de exudado ligero-moderado, tanto agudas como crónicas. Limpia la herida y reduce la carga bacteriana. ▪ Cutimed® Sorbact gel: Heridas secas o con poco exudado, crónicas y con esfacelos. *Mucha precaución en el uso de este apósito puesto que se puede adherir al lecho de la herida y no todas las personas toleran la retirada. ▪ Apósitos de plata: Heridas con signos de infección (olor, dolor, inflamación, etc.). Utilizaremos un tipo de apósito u otro en función de las características de la herida, como cantidad de exudado y localización de esta. Ejemplo: Urgotul® Ag, Mepilex® Ag, Aquacel® Ag Plus, Polymem® Ag, etc.
Colágeno:	▪ Cutimed® Epiona: Heridas crónicas sin tejido esfacelar y libre de infección. Si la herida es seca se puede humedecer con suero fisiológico. El apósito es reabsorbido por la herida.

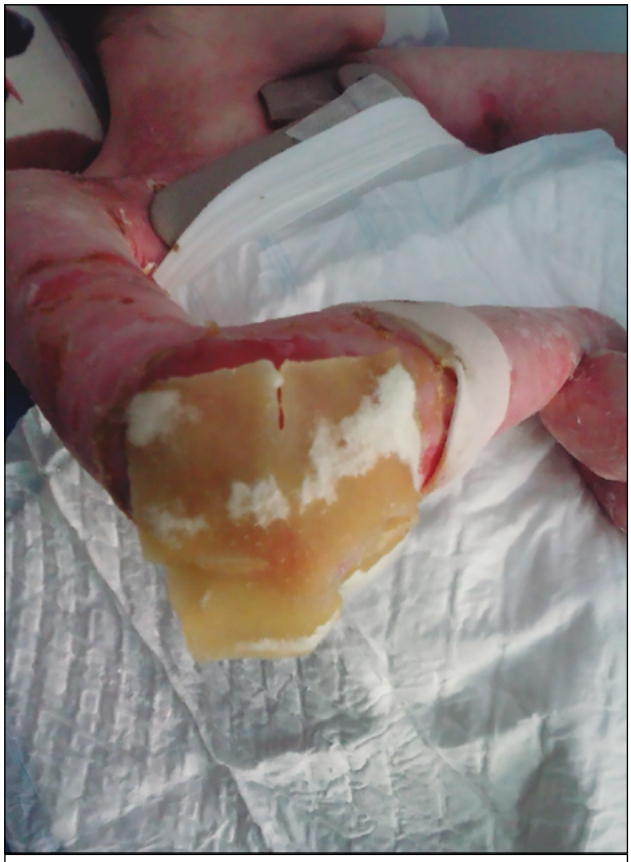


Foto 8. Apósito en herida de EB.

son las prendas a base de malla tubular, como Tubifast® Garments o Skinnies®. Cabe destacar la importancia del vendaje de manos, en el que haremos hincapié en la separación interdigital para prevenir o retrasar una de las complicaciones más frecuentes como es la sindactilia y las contracturas articulares. *(Foto 9) (Foto 10)*

Además del procedimiento de cura, las enfermeras, debemos prestar atención a otros patrones funcionales, ya que nuestra cercanía a la persona en el día a día nos va a ayudar a detectar posibles signos de alerta, por ejemplo:



Foto 9. Vendaje de manos.



Foto 10. Guante para protección y separación interdigital en EB.

CUADRO RESUMEN DE LOS CUIDADOS EN EPIDERMÓLISIS BULLOSA

1º Conocimiento de la enfermedad por parte de los profesionales sociosanitarios para programar un abordaje completo.	2º Educación a la familia y formación en la enfermedad y sus cuidados para un abordaje conjunto y centrado en la persona.	3º Prevención de las complicaciones. Atender a los diferentes aspectos de la persona que se pueden ver involucrados en la EB: ▪ Complicaciones nutricionales y digestivas. ▪ Dolor. ▪ Complicaciones musculoesqueléticas. ▪ Picor.	4º Cura completa del cuerpo haciendo coincidir con el baño (se recomienda cada 48 horas): ▪ Pinchar las ampollas (conservar el techo). ▪ Baño o ducha ▪ Aplicar crema cicatrizante. ▪ Colocar apósitos	5º Hidratación de la piel: ▪ Piel sana. ▪ Zonas frágiles. ▪ Zona pañal, zona gastrostomía, piel perilesional de la herida.	6º Protección y vendaje del cuerpo: ▪ Vendaje de las zonas con apósitos para fijación. ▪ Colocación de mallas tubulares. ▪ Colocación de Garments.

dificultad en la nutrición, la eliminación (el estreñimiento es muy frecuente en la EB, llegando a producir problemas más graves), descanso, actividad, autoconcepto, relaciones interpersonales, sexualidad, entre otros. Esta identificación de signos nos va a permitir derivar al profesional correspondiente y trabajar de manera holística teniendo en el centro de los cuidados a la persona con EB y su familia y entorno.

Esta identificación de signos, y en base a la experiencia de la Asociación DEBRA-PIEL DE MARIPOSA, nos hace poner en un lugar muy especial el abordaje de las complicaciones psicológicas y sociales.

CUIDADOS PSICOLÓGICOS EN LA EB

Las complicaciones psicológicas se hacen patentes desde el momento en el que se diagnostica la enfermedad, por tanto, es necesario el abordaje de las mismas desde el primer instante. La noticia inesperada del nacimiento de un/a hijo/a con EB hace que los padres presenten dificultad en el afrontamiento y aceptación de la situación. Esta dificultad tiene que ver con que los padres no han podido prepararse, ni mental ni emocionalmente, para esta noticia. En esta primera etapa, es necesario que los padres se sientan acompañados en las diferentes fases por las que van a ir pasando (negación, incredulidad, rechazo, culpabilidad) hasta la aceptación. El acompañamiento en este primer momento permitirá establecer estrategias y rutinas que mantengan la filosofía de crianza que habían imaginado. La forma en que los padres/madres asimilen la noticia va a tener repercusiones directas sobre su hijo/a con EB, pudiendo existir tendencia a desarrollar conductas de sobreprotección o de dificultad en la relación madre/padre-hijo/a.

Existe una segunda etapa que se inicia cuando la persona con EB empieza a tomar conciencia del significado de convivir con esta enfermedad. Aquí, es recomendable trabajar de forma conjunta con los padres/madres y sus hijos/as para dar respuestas a nuevas preguntas cómo: empezar a hablar sobre la enfermedad con su hijo/a, que está pasando y porque soy diferente a mis hermanos/as, primos/as, compañeros/as del colegio, etc. A medida que la persona con EB va madurando aparecen nuevos retos importantes que deberemos tener en cuenta: el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la expresión de su sexualidad de manera explícita, el temor al rechazo de sus iguales, la dificultad en las relaciones sociales, la tendencia al aislamiento, la falta de seguimientos médicos por la desesperanza terapéutica, la falta de adherencia al tratamiento, etc.

Por último, existe una tercera etapa que se establece cuando la persona con EB llega a su completa madurez. Aquí, las necesidades pueden manifestarse de forma distinta, pueden aparecer nuevas complicaciones clínicas hasta ahora desconocidas, falta de apoyos, un final de la vida, etc., que requerirá de un acompañamiento singular.

Todo esto manifiesta la necesidad de un seguimiento continuo por parte de un profesional de la psicología que trabaje en un primer momento con los progenitores y en segunda instancia con la persona con EB para vivir la enfermedad desde el concepto de salutogénesis y conseguir así una mayor calidad de vida.

CUIDADOS SOCIALES EN LA EB

Al igual que con las complicaciones psicológicas, las complicaciones sociales también se hacen patentes desde el momento del diagnóstico. En la mayoría de los casos, si ambos progenitores trabajan fuera del hogar, uno de ellos debe dejar su trabajo para poder encargarse de la necesidad continua de cuidados que tiene la persona con EB. Esto provoca una alteración a nivel económico y un cambio de rol en la familia. A esto hay que añadir las dificultades en el acceso al tratamiento, ya que éste no está financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en su totalidad, por lo que deben asumir el coste de algunos productos necesarios para el tratamiento y cuidado de la EB. Además, las políticas sociales existentes en España no están adaptadas a las circunstancias y necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes como la EB y la de sus familiares, dificultando la conciliación laboral y familiar, la inclusión educativa y laboral de la persona con EB, el acceso a ayudas y recursos sociales adecuados, etc. Por último, el desconocimiento de los profesionales en su zona de residencia, la baja prevalencia y la dispersión geográfica de los casos existentes generan un gran impacto (sanitario, social, psicológico, económico, etc.) en la persona con EB y su familia, pero un impacto mínimo en la sociedad, teniendo que enfrentarse cada día a situaciones complejas a las que las personas con EB y sus familiares no encuentran respuesta.

Ante esta situación, el apoyo de las trabajadoras sociales es vital desde el momento del nacimiento, ya que podrán informar a la familia de las ayudas a las que pueden acogerse por tener un/a hijo/a con esta enfermedad como, por ejemplo, ampliación de la baja maternal, medidas existentes para la conciliación laboral como la prestación por hijo/a a cargo con enfermedad grave, etc.

A medida que el bebé vaya creciendo, la trabajadora social evaluará y analizará el entorno familiar y social para poder informar a la familia de los servicios y prestaciones sociales que puedan beneficiarles en estos momentos como, el acceso a Atención Temprana, el cual podrá favorecer el desarrollo psicomotor del niño/a con EB o los beneficios que el certificado de discapacidad o la Ley de Dependencia pueden aportarles en su día a día (ayuda a domicilio, prestaciones o ayudas económicas, etc.).

Ante la escolarización de un niño/a con EB, será necesario tener en cuenta algunas necesidades específicas para poder planificar y proveer de recursos adecuados. Hablamos en este sentido de: recursos personales (profesionales que le apoyen en el centro), recursos materiales (adaptación del mobiliario en caso de necesidad, de material escolar, etc.), adaptaciones espaciales (eliminación de barreras arquitectónicas) y adaptaciones temporales (establecer ritmos de trabajo apropiados a las posibilidades de cada niño/a.) En este sentido, será fundamental la coordinación de todos los agentes del entorno que interactúen con el/la niño/a con EB (Atención Temprana, Servicios Sociales, Centro Educativo, Centro de Salud, etc.) ya que favorecerá la inclusión y desarrollo pleno del niño/a durante su etapa educativa.

Posteriormente, y a medida que la persona con EB va alcanzando la edad adulta, podrán aparecer ciertas dificultades como el acceso al mercado laboral o la participación social. En este sentido, la trabajadora social podrá ofrecer información sobre la oferta formativa y de empleo existente, así como información sobre las políticas sociales en materia de empleo para personas con un certificado de discapacidad reconocido. Tampoco debemos olvidar las dificultades derivadas de las manifestaciones clínicas que provocarán la pérdida en su autonomía personal. Muchas personas con EB necesitan apoyo de alguien para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como, por ejemplo, lavarse los dientes, vestirse, atarse los cordones o abrir una botella. En este sentido, el papel de la trabajadora social y/o de la terapeuta ocupacional, será de gran ayuda ya que puede informar acerca de cómo acceder a ayudas técnicas o productos de apoyo que fomenten su autonomía personal, así como proporcionar información sobre ayudas o subvenciones económicas para adaptaciones en el hogar, automóvil, etc. Gracias a las ayudas técnicas, pequeños instrumentos o utensilios (a veces incluso de elaboración casera), como abre botellas especiales, manoplas, etc. el día a día a las personas con EB se hace más sencillo, llegando en muchos casos a ser personas completamente independientes. *(Foto 11)*

Por tanto, contar con el apoyo de trabajadoras sociales será fundamental para el abordaje de la EB, ya que son profesionales que conocen los entresijos en la legislación y son capaces de analizar las circunstancias de las personas con EB y de sus familiares, identificar situaciones de riesgo, evaluar su entorno y valorar las posibles complicaciones clínicas que podrán afectar en la autonomía personal de la



Foto 11. Oliber®-Ayuda técnica para personas con EB.

persona con EB. Será la profesional encargada de informar, orientar y asesorar sobre los recursos y ayudas sociales disponibles, así como, facilitar y promover los recursos necesarios que permitan el desarrollo pleno en la sociedad tanto de las personas con EB como de sus familiares.

CONCLUSIÓN

Dada las características de la enfermedad, los cuidados en EB se deben llevar a cabo por profesionales sociosanitarios y no recaer de forma íntegra en la persona afectada y su familia, como ocurre en muchos casos, ya que esto conlleva sobrecarga del cuidador, dificultad en las relaciones familiares, etc. Los profesionales sociosanitarios debemos apoyar desde el primer momento con nuestro conocimiento y habilidades en busca de la promoción de la salud, la prevención de las complicaciones, la disminución del número de ingreso... en definitiva, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la persona afectada por EB y su familia. *(Foto 12)*



Foto 12. Equipo DEBRA-PIEL DE MARIPOSA con familia.

Bibliografía

[1] Baquero Fernández, Carmen. Servicio de Neonatología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. Herrera Ceballos, Enrique. Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. López Gutiérrez, Juan Carlos. Departamento de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid. De Lucas Laguna, Raúl. Unidad de Dermatología Infantil. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Romero Gómez, Javier. Unidad de Dermatología. Hospital Costa del Sol. Málaga. Serrano Martínez, M.ª Concepción. Estomatología. Clínica Dental Nova. Valencia. Torrelo Fernández, Antonio. Servicio de Dermatología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. Guía de atención clínica integral de la Epidermólisis bullosa hereditaria.